



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : شيرين على بديع سعدى
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : المطرية
رقم البطاقة : 28407160100701 رقم التليفون : 01002563606
العنوان : ممممممممم
العمر (تاريخ الميلاد) : 16-07-1984 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 10-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: شيرين على بديع سعدى National ID: 28407160100701	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بمحافظة تحقيق الشخصية

شبرين
على بديع سعدى عبدالله
٣٠ ش - عزبة بشتا
المطرية - القاهرة

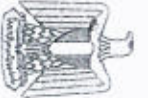


٢٨٤٠٧١٦٠١٠٠٧٠١

JE9472092



٢٠٢٢/٠١
٢٨٤٠٧١٦٠١٠٠٧٠١
حاصلة على ليسانس أدبي
قسم اللغة الإنجليزية وآدابها
بمحافظة



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠١/٠٣



National Women's Health Initiative
Pathology Lab
معمل باثولوجي المبادرات القومية لصحة المرأة

Pathology Report

Age: 36 years.

Date(reported): 6/6/2021

Hospital Number: 61476

شترين على بنوع

clinical data: Left breast mass.

type: Slide Reversion.

(Received): 29/5/21

Number:SR-207/21

examination:

cedure: slide revision

localization: Left breast mass

tumor extent

Number: N/A

Size:

Skin involvement:

distance from margins:

ymph nodes number and size:

Additional pathologic findings:

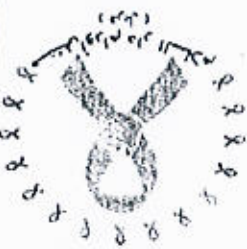
immunohistochemistry technique:

scopic examination:

histological type: Invasive duct carcinoma

grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II

invasion: Not evident



Name: شيرين علي بديع سعدي			
MR. : 7581			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحية طيبة وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient has no available data for the 01/06/2026 note; only a brief mention that zoladex was administered today with the next dose scheduled for 24/08. The patient has a history of left-sided cT3N1 breast cancer that is hormone receptor positive and HER2 positive. She underwent left mastectomy with a ypT1N2 pathology. Adjuvant therapy included 6 cycles of chemotherapy plus 3 cycles of hormone therapy, followed by adjuvant anti-HER2 therapy with Kadcyła, which was completed at cycle 17 in October 2022. She began hormonal therapy in January 2022 and, due to high-risk features, is scheduled to continue hormonal treatment for a total of 7 years, with the next dose of Femara due in two months. The patient has completed 17 cycles of anti-HER2 therapy.			
تحريراً في ,			
التاريخ :		21-09-2026	
الوقت :			
هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر		الطبيب المعالج :	
يعتمد ,			

25773253 - 25744742 - 25790935 : ٢٥٧٧٣٢٥٣ - ٢٥٧٤٤٧٤٢ - ٢٥٧٩٠٩٣٥

1/1

1/1

Elia Anis

Shady Elia Anis

Prof. Dr. Elia Anis Isnak

Prof. Dr. Shady Elia Anis

Tru cut biopsy, INFILTRATING DUCT CARCINOMA, GRADE II.

Diagnosis :

There is moderate desmoplasia. There is peritumoral lymphocytic infiltrate around 10%.
The index is low.
There is moderate desmoplasia. There is peritumoral lymphocytic infiltrate around 10%.
There is moderate desmoplasia. There is peritumoral lymphocytic infiltrate around 10%.
There is moderate desmoplasia. There is peritumoral lymphocytic infiltrate around 10%.
There is moderate desmoplasia. There is peritumoral lymphocytic infiltrate around 10%.

Microscopic :

Tru cut biopsy, measured up to 2 cm long. Totally submitted.

PATHOLOGY REPORT

Patient ID : 432158

Receiving Date : 10/10/2021

Referring of Specimen : Tru cut biopsy

Referring of Specimen : Tru cut biopsy

Referring of Specimen : Tru cut biopsy

Gender : Female

Analyst ID : 432158

Analyst ID : 432158

Dr. Shady Elia Anis
Assistant Professor of Pathology
M. Sc. Pathology, Ass. Prof. of Pathology, Faculty of Medicine
Suez Canal University, Suez, Egypt

Dr. Shady Elia Anis
Assistant Professor of Pathology
M. Sc. Pathology, Ass. Prof. of Pathology, Faculty of Medicine
Suez Canal University, Suez, Egypt

Shady Elia Anis

Elia Anis Isnak

A N



Referring: *Sherrine Ali Bader*

ID: 2848964

Date: 15/03/2021

REPORT

^{99m}Tc-MDP W.B. Bone Scan

History:

Female patient with history of left breast mass.

Technique:

Whole body images were acquired 3 hours after injection of 740 MBq of the tracer.

Findings:

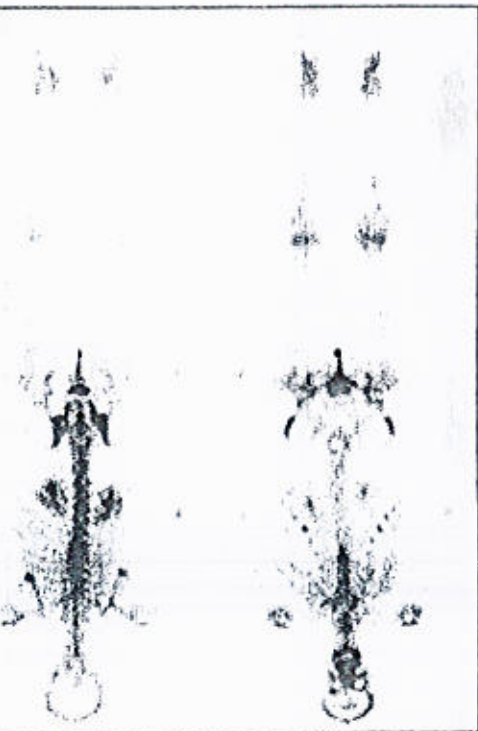
No features of bone metastases detected.
Degenerative changes of the spine are noted.
Osteoarthritic changes of the knees and shoulders are observed.

Conclusion:

No scintigraphic evidence of bone metastases.

Dr. Mona Saied, MD

Dr. Heba Safah, MSc



MEDICAL ONCOLOGY	SIGNATURE	RADIOLOGY	PATHOLOGY
W. J. L. O.		W. J. L. O.	

MDT OUTCOME & PLAN

POST
+ SWAY b TDM-1
LH2H - AI

COMMENT:

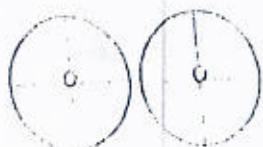
STP 6 cycles Fardue - Carbo + 3 HP
→ Wt MAN: YP T1N2

HTC	PR	HER	KITV
1/8	5/8	3/4	30%
Metals Workup:			
SM:			

YF1 N2 Mo

Clinical Data

Name	عبدالله
Age	35
MRN	1904/2021
ID	11-50277-1
Co	5N3.V17.1-2.1
Morbidity	



MDT FORM

1-1-15

الكلية الطبية
الجامعة الأردنية

الكلية الطبية
الجامعة الأردنية



No gross hepatic or osseous metastatic deposits.

Few bilateral tiny millimetric benign looking pulmonary nodules, for follow up axillary lymphadenopathy.

Left breast heterogeneous parenchymal enhancement with ipsilateral axillary lymphadenopathy.

No little or sclerotic bone lesions.

No abdominal or pelvic masses or collections.

Small functional cyst.

Normal appearance of other pelvic organs. IUCD is seen in place. Right adnexal outpouching.

Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticula. Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.

Diameter.

Changes. Few right renal small stones are seen, the largest measures about 4 mm in diameter.

Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no back-pressure changes. Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.

No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.

Metastases.

Normal homogenous enhancing portal vein and its main branches as well as its main branches or contour irregularities.

Enlarged liver with homogenous low CT texture density. Fatty infiltration. No focal lesions or contour irregularities.

Abdomen and pelvis:

Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.

No evidence of pleural effusion. Local thickening of the aorta seen.

No free or mural lymph nodes.

Normal size and bilateral basal lung parenchymal bands.

Left side measures about 5 mm in diameter.

Two pleural based lobes pulmonary nodules are seen, the largest on the left side measures about 2.5 x 2.5 cm.

Left breast heterogeneous parenchymal enhancement.

Chest:

Known case of breast cancer.

ABDOMEN & PELVIS REVEALED:

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST.



Dr. Kana Fathy

Prof. Dr. Manal EL-Mahdy

Ratio 7: 30% nuclear reaction

strong Intensity > 10%, complete membrane reaction (score

ER: moderate Intensity 20% nuclear reaction (Allred score 5/8)

ER: moderate Intensity 80% nuclear reaction (Allred score 7/8)

markers:

invasive duct carcinoma GII.

breast mass, slide revision:

revision:

additional pathologic findings: micropapillary features

Free /DCIS/ invasive carcinoma

Resection Margins:

lymph node involvement:

Skin involvement:

Size:

Number:

tumor extent

Ductal carcinoma in situ: 5%